

II. 사업계획

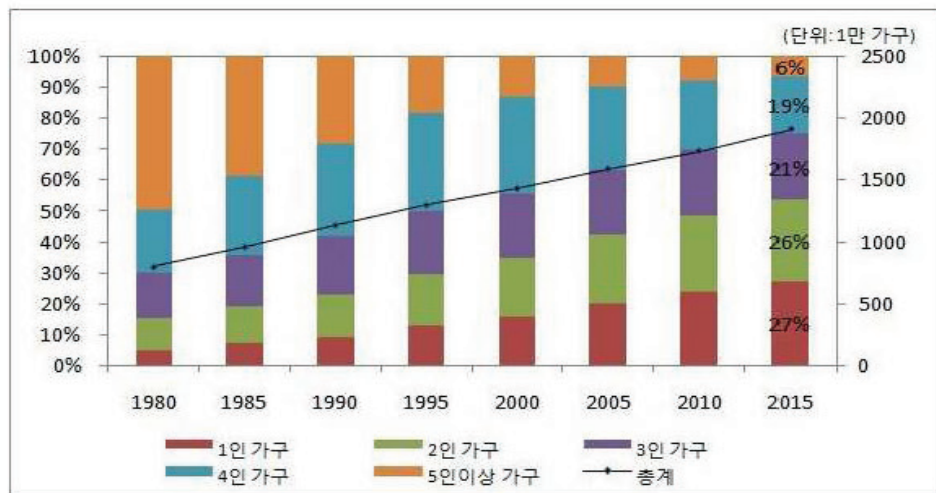
1. 사업명 : 50대 독거남 건강관리 및 사회관계망 구축 프로젝트 <아름다운 재도약>

2. 사업의 필요성

1) 대상자 욕구 및 문제점

(1) 혼자사는 중년층의 급격한 증가

통계청의 ‘2015년 인구주택총조사’에서는, 1인 가구가 전체 가구의 27%를 차지한 반면에 5인 이상 가구는 6%에 그쳤다. 그리고 지난 35년 동안 전체 가구수는 인구수보다 더 빠른 속도로 증가하고 있는데, 이 역시 1인 또는 2인으로 구성된 소규모 가구가 급속하게 늘어났기 때문이다.



<가구 구성의 변화 추이(1980~2015)>, 자료: 통계청/인구주택총조사(2015)

더욱 문제가 되는 것은 1인 가구의 빠른 증가를 이끄는 연령대가 노년층이나 청년층이 아닌 40~50대라는 점이다. 2015년 현재 총인구를 5살 간격으로 나눠 각 연령 구간별 인구 중에서 1인 가구의 비율을 계산해보면 전체 평균이 10.5%로 나온다. 그런데 결혼을 해서 가족을 이루며 살고 있어야 할 40~50대까지 1인 가구 비율이 9.9%~11.6%에 이른다.

	2005	2010	2015
20세 미만	1.4%	1.2%	1.1%
20대	21.4%	18.6%	17.0%
30대	19.9%	19.0%	18.3%
40대	15.0%	15.0%	16.3%
50대	11.5%	14.1%	16.9%
60대	13.6%	12.8%	12.8%
70대 이상	17.3%	19.3%	17.5%

<1인가구의 연령대별 비중>

자료: 통계청/인구주택총조사(2015)

또한 같은 기간 20대와 30대의 비율이 일정한 것과 달리, 50대의 경우 해가 지날수록 급격한 증가세가 나타난다. 현재 30대인 계층에서는 나이 들어도 1인가구 비율에 사실상 큰 변화가 없는데 이는 해당 연령층에서 '홀로 사는 삶'을 스스로의 방식으로 받아들인 사람들의 비율이라고 보아도 무방하다. 그러나 40~50대의 경우 자신의 삶과 가정 및 직장을 둘러싼 사회경제적 환경의 급격한 변화에 따라 혼자되는 삶을 타의로 선택하는 경우가 많을 수 있다.

혼자 사는 40~50대는 다인가구의 중년보다 심리적 안정성이 훨씬 떨어진다. 소득·고용·주거 불안 등 사회경제적 어려움 또한 청년이나 노인 1인 가구 못지 않게 심할 수 있다. 특히 이러한 상황이 지난 10 ~ 15년간의 짧은 기간에 걸쳐 급격히 발생했다는 점에서 사회복지적 차원의 대응이 필요하다고 할 수 있을 것이다.

(2) 50대 1인가구의 사회적 문제

2015년 보건사회연구원에서 발간한 「1인가구 증가에 따른 신사회적 위험 대응전략」 보고서에 따르면 중년기인 40-50대 1인가구의 경우 미혼이나 이혼으로 인해 1인가구가 되는 비중이 높으며 전반적으로 자녀양육 및 스스로에 대한 노후준비가 미흡하고 국민연금, 퇴직 및 개인연금 가입비중이 상대적으로 낮은 편이다. 또한 낮은 취업률과 높은 실업률이 다른세대에 비해 특징적으로 나타나고 있으며 특히 건강과 의료의 측면에서 볼 때 1인가구가 다인가구에 비해 그 건강수준이 크게 낮은 편으로 보건의료비의 지출 비중이 높고 만성질환율, 우울, 자살위험도 등이 높게 나타났다.

50대 1인가구는 세대전체를 통틀어 삶의 만족도지수가 가장 낮고, 거주지에 있어서도 지하 및 옥탑의 거주비중이 가장 높았다. 또한 청년층 1인가구가 자신의 선택에 의해 1인가구로서의 생활양식을 가져가는 반면 중년층 1인가구는 노년 1인가구와의 특성을 같이 하고 있고 단지 문제의 강도에 있어서 노년층에 비해 전반적으로 낮았다.

40대보다 50대에 들어서면서 1인가구가 가지고 있는 부정적인 특성들이 보다 확연하게 부각되고 있으며 중년 1인가구가 가지고 있는 소득불안정성, 고용불안정성, 건강문제, 주거불안정성과 주거환경의 열악함 등을 구조적으로 해결하지 않는다면 이들이 노년기에 진입하면서 현재 노인 1인가구가 직면하고 있는 노인빈곤이나 불건강, 그리고 주거문제 등을 답습하게 될 것으로 보인다.

이미 50대의 우울 의심률 및 자살생각률 또한 급증하고 있다. 서울시의 경우 고독사 확실사례는 2013년 기준 연간 162건으로 이틀에 한 꼴로 발생하며, 의심 사례는 연간 2,181 건으로 하루에 6건씩 발생하고 있다. 또한 확실사례중 남성이 137건, 여성이 21건으로 남성의 비율이 압도적으로 높게 나타났다.

성별	사례수(건)	비율(%)
남	137	84.57
여	21	12.96
미상	4	2.47
합계	162	100.00

서울시 고독사 확실사례 성별, 현황(건, %)

자료: 서울시복지재단/고독사 실태파악 및 지원 방안 연구(2016)

중년 1인가구는 미혼, 이혼, 사별로 인해 발생하며 외로움과 사회적 고립감을 느끼는 상황에 노출되지만, 사회적 지지 환경은 부족하다. 또한 중년 1인가구는 자살생각율이 타세대보다 월등히 높으며, 사회적 무게감(고용의 불안정성 등)을 느낌과 동시에 사회적 위기(이혼, 사별 등)를 경험하는 상황에 놓여 있으므로 중년 1인가구에 대한 정서적 지지와 사회관계망의 확충은 일자리 창출 등 경제적 해법과 별개로 함께 이루어져야할 것이다.

(3) 지역의 문제해결 요구

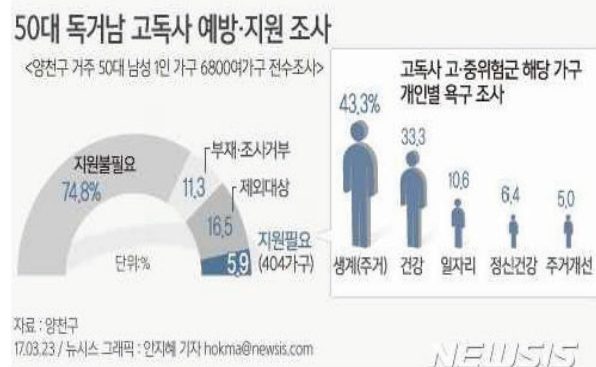
양천구가 2017년 지역 내 거주 50대 남성 1인가구 6,800여가구를 전수조사한 결과에 따르면 생계와, 건강, 일자리 등 욕구가 크게 나타났으며, 이러한 조사결과에 따라 ‘양천 50대 독거남 지원협의체’를 구성해 통합 사례 관리를 진행해나갈 예정이다.

양천구가 지난달부터 양천구 거주 50대 남성 1인 가구 6,800여가구를 전수조사를 실시한 결과 지원이 필요한 가구는 404가구(5.9%), 조사를 거부한 가구는 198가구(2.9%), 부재중인 가구는 576가구(8.4%)로 나타났다.

이 가운데 지원이 필요한 404가구중

고독사 고·중위험군에 해당하는 50대 독거남 96가구를 대상으로 개인별 욕구를 조사한 결과 생계·주거에 대한 욕구 61명(43.3%), 건강에 대한 욕구 47명(33.3%), 일자리에 대한 욕구 15명(10.6%), 정신건강에 대한 욕구 9명(6.4%), 주거개선에 대한 욕구 7명(5%), 가족관계 회복 등에 대한 욕구 등 2명(1.4%) 순이었다.

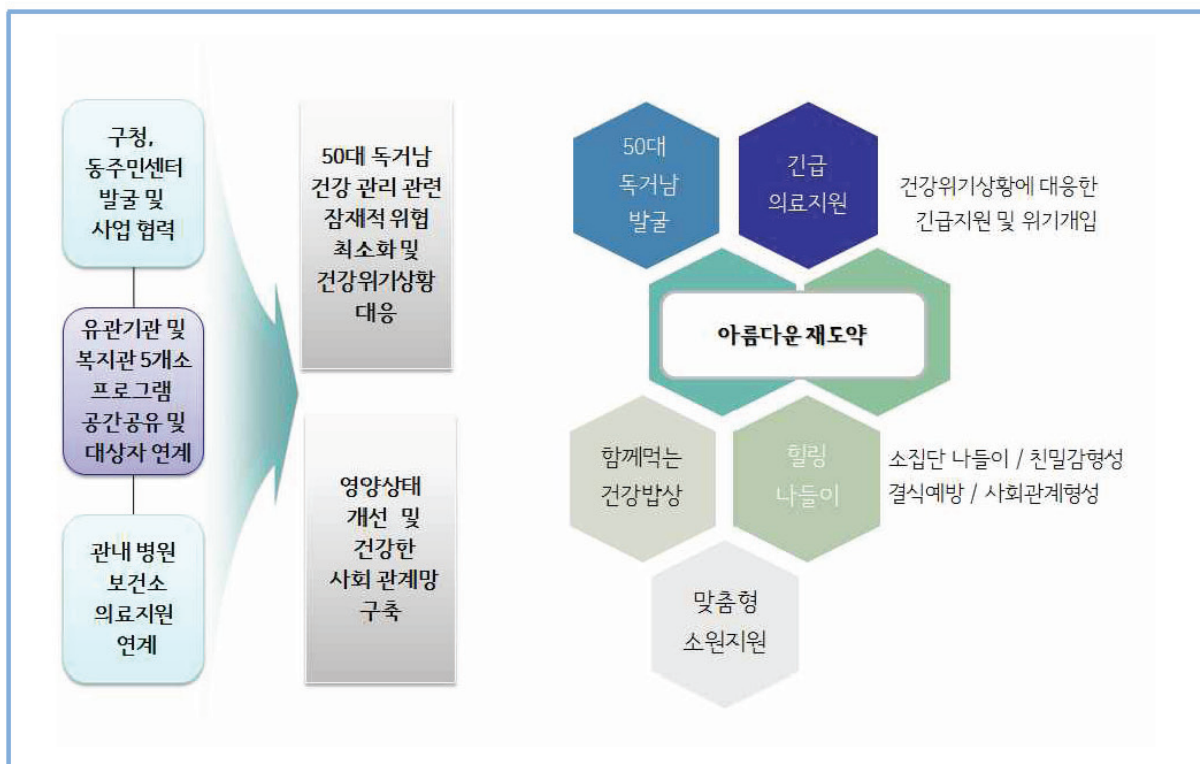
2017-03-23 【서울=뉴시스】 박대로 기자



본 복지관은 양천구에 위치한 종합사회복지관으로서 지역의 문제에 선제적으로 대응하고자, 50대 남성 1인가구가 직면하기 쉬운 일상적 문제인 건강관리와 관련하여 본 사업을 운영하고자 한다.

건강관리 및 예방 차원에서 혼밥 레시피를 주제로한 함께먹는 밥상모임을 정기적으로 운영하여 50대 독거남의 영양상태 개선 및 건강한 사회 관계망을 구축한다. 또한 초기 대상 발굴단계에서 발견된 건강위기상황에 대해서는 긴급 의료지원 및 위기개입이 가능하도록 함으로서 50대 독거남의 건강관리와 관련하여 잠재적 위험을 최소화하고, 드러난 문제를 실시간으로 해결해나갈 예정이다.

<사업체계도>



3) 경험적 근거

신목종합사회복지관은 저소득층 주민과 일반 아파트에 중산층이 거주하는 혼합형 지역 내에서 다양한 욕구와 문제해결을 위하여 복합적이고 종합적인 사회복지사업을 수행중인 지역사회복지관이다. 또한 2000년 10월 서울시 최초로 선정된 장애인기능특화복지관이자, 부설시설로 외국인근로자센터를 운영하는 종합사회복지관으로써 지역사회 안에서 빈곤, 장애, 다문화가정 등 취약계층에 대한 다각적인 서비스를 제공하고 있다.

2012년부터는 서울시 지원을 통해 희망은돌사업을 운영함으로써 지역 내 \위기 대상자에 대한 긴급기금지원으로 한부모, 독거, 장애인, 저소득 가정 등 위기 가정 신규대상자 발굴과 지원의 역할을 수행해나가고 있다. 특히 질병, 부상, 사고에 대한 의료비 직접지원을 통해 복지사각지대에 놓인 위기가정이 사회적 위험을 극복해 나가는 데 그 역할을 다하고 있다.

2015-2017년 3년에 걸쳐 보건복지부 지원을 통해 독거노인친구만들기사업을 운영하고 있다. 지역 내에서 보호받지 못하고 있던 실질적 독거노인을 전사적으로 발굴하고, 사례관리 및 개별개입을 실시하였으며, 다양한 집단프로그램 운영 및 우울증 관련 의료지원 등을 통해 지역 내 독거 어르신의 우울증 감소 및 사회적 관계망 복원이 이루어지도록 돕고 있다.

2011-2013년 3년간은 서울시 및 양천구청 지원을 통해 노인우울증자살예방 프로그램 “내 마음의 행복찾기”를 운영하였으며, 봉사자를 활용한 결연방문 및 정서지원으로 노인문제(자살, 우울증)예방을 위해 노력하였다.

2015년에는 KBS강태원복지재단 지원으로 독거 및 취약계층 어르신의 고독사(孤獨死) 예방을 위한 지역중심 돌봄 공동체 구축 프로젝트 『Happy Village』를 운영하였다. 이를 통해 지역 내에서 돌봐주는 가족과 이웃이 없어 외로움과 일상생활에서의 크고 작은 어려움을 경험하던 어르신들을 위해 지역사회가 공동체차원에서 개입할 수 있는 계기를 마련하였다.

사각지대 취약계층의 발굴 및 지원, 정서적지지, 사회적 관계망 형성 등과 관련한 상기와 같은 다양한 사업 수행 경험을 바탕으로 양천구 거주 중인 고독사 고·중 위험군 50대 독거남의 건강 및 의료적 문제상황에 대한 솔루션을 제시한다.

또한 단편적인 1회성 지원에 그치는 것이 아니라 다양한 주체가 협업을 통해, 집단 활동 및 사회적 관계 형성등을 지원함으로써 지역사회 내에서 50대 독거남을 지지할 수 있는 체계를 구축해나갈 예정이다.

4) 본 사업과 관련된 지역 복지자원 현황

본 사업은 양천구 내 위기상황에 노출될 위험이 높은 50대 독거남의 의료 및 건강문제를 해결하려 하며 이를 위해 지역 사회 내 관련 유관기관 및 관공서 등과 협업해 나갈 예정이다.

대상자 발굴 및 추천과 관련하여 기관 내 사례관리팀의 자체발굴 외에도, 1차적으로는 양천구 내 각 찾아가는 동주민센터 복지 플래너 및 방문복지팀의 대상자 추천 의뢰를 받아 사업을 수행할 예정이며, 3월 실시한 독거남 전수조사와 관련하여 양천구청 관련부서 및 양천사랑복지재단과 대상자 발굴과정에서 협력해나간다.

또한 프로그램 진행단계에서는 의료지원이 필요한 50대 독거남에 대한 진단 및 지원과 관련해서는 서남병원 및 양천구 보건소 등과 연계하고자 하며, 집단 프로

그럼 진행시 신정2동 및 신정7동 등 인근 주민센터와 프로그램 공간 공유에서부터 사후관리에 이르기까지 긴밀한 연계가 이루어질 예정이다.

양천구 내 종합사회복지관 5개소 및 장애인복지관과는 사업 단계 전반에 걸쳐 대상자 발굴 및 자원 연계, 서비스 의뢰 등 사례관리측면의 협력관계를 이어나갈 예정이며 양천구 내 50대 독거남을 위한 종합적인 지원이 가능하도록 할 것이다.

3. 서비스 지역, 서비스 대상 및 실인원수

- 1) 서비스 지역 : 서울특별시 양천구 **신정1~7동**
- 2) 서비스 대상 : 양천구 **신정 1~7동**에 거주 중인 고독사 고·중위험군 50대 독거남 15명
- 3) 서비스 대상 선정기준 및 방법(과정):
 - 양천구 전수조사를 통해 발굴된 고·중위험군 50대 독거남 우선 선정
 - 사례관리팀 방문조사 및 사례발굴을 통해 선정
 - 양천구 내 동주민센터 및 유관기관 의뢰 협력을 통해 선정

4) 실인원수

대상구분	서비스대상자 산출근거	단위수(명)
① 일반대상	양천구 거주 50대 남성	39,392 ¹⁾
② 위기대상	일반대상 중 1인가구	6,800 ²⁾
③ 표적대상	위기대상 중 고독사 고·중위험군 50대 독거남	96 ³⁾
④ 실인원수	표적대상 중 신정1~7동에 거주하며 참여를 희망하는 인원	15

4. 사업 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
1. 50대 독거남에 대한 긴급 의료 지원 및 사후관리를 실시한다.	1-1. 건강위기상황에 놓인 독거남 발굴 (15건/15명)	50대 독거남의 건강위기상황 해소
	1-2. 50대 독거남 긴급의료지원 (10건/10명)	
	1-3. 정기적인 상담 및 사후관리 (10명 X 월1회 X 6월 = 60건/60명)	
2. 50대 독거남의 결식 예방 및 건강한 사회 관계망을 구축한다.	2-1. 함께먹는건강밥상 (12명 X 10회= 10건/120명)	50대 독거남의 결식 예방 및 사회 관계형성
	2-2. 힐링나들이 (6명 X 2회 = 2건/12명)	
	2-3. 맞춤형 소원지원 (12건/12명)	

1) 양천구 연령별 인구현황, 양천구청 (2017년 3월)

2) 50대 1인가구 전수조사, 양천구청(2017년 3월)

3) 상동